

TEMA 4.10 • DERMATOLOGÍA

Dermatitis Atópica

PERFIL EUNACOM 6.01.1.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Dermatitis Atópica

La Dermatitis Atópica (DA) es una enfermedad cutánea intensamente genética reactivo-inmunológica sistémica asediada fuertemente por la hipersequeidad del tegumento general.

Evolución Geográfica Clínica de Referencia (Las Fases de Edad)

El compromiso de la exacerbación atópica cambia sus manifestaciones de acuerdo al comportamiento biológico anatómico mecánico de roces o pliegues por edades cronológicas.

- **En la Época de Lactantes y Bebés:** Reacción inflamatoria comandada fuertemente mecánica frente al asedio en **Zonas Extensoras expuestas al roce / gateo y Cama.** - Predilección inmensa por impactar: Cuero cabelludo descamativo posterior rasguñado en cuna, caras laterales extensoras de Rodillas / Codos en el gateo, e invadiendo profusamente la clásica zona media de **Las Mejillas y los Cachetes infantiles hiperqueratósicos.** - **En Niños Preescolares Mayores (>2 años) a Estadío Adulto Mayor:** El cuadro muta crónicamente y se desplaza migrando perimetralmente reaccionando ahora por roce químico exógeno frente al estímulo macerado ácido del **Sudor acumulado**, habitando netamente en **Zonas Internas Flexoras (Pliegues corporales de bisagra profunda).** - Afectación universal típica de la Fosa Poplítea posterior pierna, flexura de codos Antecubital, y profundidades del Cuello perimetral.

Clínica Elemental de la Piel

Su tríada sintomática cursa brotes rojos consistentes en erupción y salpullidos de **pápulas reventadas e innumerables micro exoriaciones por rasquido severo.** La inflamación crónica incesante conduce inexorablemente en casos no controlables a la gran **Liquenificación extrema atópica paquidérmica** e injurias cromáticas discrómicas subyacentes hiperpigmentadas enrojecidas permanentes. - **Colonizador Microbiano Basal:** Esta injuria local es altamente profusa y agravada fuertemente debido a su constante masiva **colonización por estafilococias activas* (Staphylococcus aureus) **el cual empeora los cuadros febriles a diferencia de población cutánea sana.**

Los Grandes Estigmas Periféricos Universales de la Atopia Excesiva

El marcador basal pernicioso causante subyacente que rige todo es universal: LA PIEL SECA (Xerosis). Es transversal el pilar máximo de todo atópico basal. **Acompañado adjuntamente con frecuencia de: 1. Queratosis Pilar (Piel de Gallina en muslos gruesa).** **2. Marcador Facial orbitario del Doble Pliegue Ocular Infraorbitario permanente de Dennie-Morgan.** **3. Despigmatación temporal parche facial y brazo denominada Pitiriasis Alba (Las máculas manchas blancas transitorias secas de cachete).** **4. Estigmas orales mucosos en remoción como la Lengua Geográfica / Despapelada lisa saltaría.** **5. Co-asociación atópica cruzada ineludible (Marcha Atópica): Triada Asmática reactiva y/o cuadros sistémicos de Rinitis alérgica perenne asfixiante estacional y urticarias severas**

alimenticias.

Protocolo de Escalera Terapéutica en Atopia (Tópicos)

- **Medida Principal N°1 Transversal de la Historia Universal (Pilar de Oro Básico): Obliga la interrupción férrea masiva de la desestabilizante piel con la adosación gruesa diaria y repetitiva impuesta del uso general en postbaño húmedo de La CREMA HUMECTANTE / Emolientes Neutros Sin Olor Vaselineados gruesos. Es preventivo y resolutorio superior asintomático por arrastre.**
- **Escalón de Rescate en Zonas Focales Inflamadas Rojas (El Brote local agudo en curso reactivo severo): Como medida a nivel primario exigida supresora desinflamando se recetan de asalto y base reactiva por días alternos a los Corticoides Tópicos directos untados (Altas de potencias como betametasona/clobetasol en liquenes graves adultos, o baja potencia Hidrocortisona en cara pediátrica leve rojiza infante).**
- **Escala Terciaria - Fallas a Línea 2: Inmunomoduladores alternantes tópicos puros no esteroidales sin atrofia dermatológica como Inhibidores Calcineurina de placa base (Tacrolimus o Pimecrolimus) y Crisaborol al bloquear fosfodiesterasa tópica inmune desinflamable limitados crónicos.**
- **El Escalador Extremo Terminal Hospitalario Biológico Subcutáneo: En atopia adulta invalidante crónica brutal descamativa sin reacción se deriba masivamente internándolo sobre las moléculas caras sintéticas Vía Inyección de inhibición Blanco Inmunológica Anti-Interleucinas sistémicas Biológicas (El uso directo bloqueador por anticuerpo Dupilumab general biológico de última fila o inhibidores citostáticos JAK por Ruxolitinib* en vía sistémicas alternadas terminal. Adicionando la Fototerapia integral controlada general ultravioleta).**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es la distribución de las lesiones en un lactante con dermatitis atópica?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Dermatitis Atópica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- En lactantes la dermatitis atópica afecta zonas extensoras como mejillas, codos y rodillas.
- En adultos y niños mayores las lesiones se desplazan a las zonas flexoras como fosa cubital y poplítea.
- La piel seca o xerosis es el signo de atopia más frecuente y debe buscarse siempre.
- El doble pliegue de Dennie-Morgan en el párpado inferior es un signo de atopia característico.
- La crema humectante es la medida más importante del tratamiento de la dermatitis atópica.
- Los biológicos dupilumab y tralokinumab están indicados en casos graves y refractarios.
- Los corticoides tópicos se usan durante las exacerbaciones y la humectación es continua.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DERMATITIS ATÓPICA)

PREGUNTA 1

¿Cuál es la distribución de las lesiones en un lactante con dermatitis atópica?

- A) Zonas flexoras como la fosa cubital, poplítea y pliegues del cuello
- B) Palmas y plantas con lesiones simétricas que respetan el dorso
- C) Zonas extensoras incluyendo mejillas, codos, rodillas y cuero cabelludo
- D) Zona centrofacial con eritema en mariposa que respeta el surco nasogeniano
- E) Mucosas orales con lesiones reticulares blanquecinas bilaterales

PREGUNTA 2

¿Cuál es la medida más importante en el tratamiento de la dermatitis atópica?

- A) Los corticoides tópicos de alta potencia aplicados dos veces al día continuamente
- B) Los antihistamínicos orales de segunda generación para controlar el prurito
- C) La crema humectante aplicada regularmente como base del tratamiento
- D) Los antibióticos tópicos para prevenir la sobreinfección bacteriana
- E) Los inmunosupresores sistémicos como ciclosporina desde el inicio

PREGUNTA 3

¿Cuál es el signo de atopía más frecuente en la dermatitis atópica?

- A) La queratosis pilar en cara lateral de brazos y muslos
- B) El doble pliegue de Dennie-Morgan en el párpado inferior
- C) La piel seca o xerosis generalizada del paciente atópico
- D) La lengua geográfica con áreas de descamación lingual
- E) El patrón de eccema numular con lesiones circulares en tronco

RESUMEN: DERMATITIS ATÓPICA

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel con fuerte componente genético y atópico, caracterizada por piel seca, eccema pruriginoso y períodos de exacerbación y remisión. La distribución de las lesiones varía con la edad: en lactantes afecta las zonas extensoras incluyendo mejillas, cuero cabelludo, codos y rodillas. En niños mayores y adultos las lesiones migran a las zonas flexoras, especialmente la fosa cubital, la fosa poplítea y el cuello. Los signos de atopía que deben buscarse son la piel seca o xerosis que es el signo más frecuente, la queratosis pilar en brazos y muslos, la lengua geográfica y el doble pliegue de Dennie-Morgan en el párpado inferior. El tratamiento se basa en la humectación como medida más importante, combinada con corticoides tópicos durante las exacerbaciones. Para los casos graves refractarios están disponibles los biológicos dupilumab y tralokinumab que bloquean la interleuquina trece. El rascado crónico puede generar liquenificación secundaria.